

表2 肺寄生虫症の治療

寄生虫症	第一選択薬	第二選択薬
肺吸虫症	praziquantel 1回25 mg/kg, 1日3回, 2~3日	
トキソカラ症	albendazole 1回5 mg/kg, 1日2回または3回, 4~8週間 食事とともに服用する。 28日間連続服用し, 14日間の休業期間を設ける	albendazole 1回400 mg, 1日2回, 5日間 mebendazole 1回100~200 mg, 1日2回, 5日間
糞線虫症	ivermectin 1回200 μ g/kg, 1回投与（空腹時） 2週間後に再度同量を服用*1	albendazole 1回400 mg, 1日2回, 7日間
回虫症 鉤虫症	pyrantel pamoate 1回10 mg/kg, 1回投与	albendazole 1回400 mg, 1回投与 mebendazole 1回100 mg, 1日2回, 3日間 または1回500 mg, 1回投与 ivermectin 1回150~200 μ g/kg, 1回投与（空腹時）
イヌ糸状虫症	多くは病理診断されるため, 内服治療を必要とすることは少ない。	もし使用するなら diethylcarbamazine 2 mg/kg, 1日3回, 12日間
リンパ管 フィラリア症	diethylcarbamazine 1回2 mg/kg, 1日3回, 12日間 マレー糸状虫の場合 1 mg/kg, 1日3回, 12日間*2	

太字：幼虫移行症, *1：播種性の場合には反復投与を考慮する, *2：消化器症状, 発熱, リンパ管・リンパ節炎, 辜丸・副辜丸炎などの副作用が強く出ることがあるため。

(*Necator americanus*), ズビニ鉤虫 (*Ancylostoma duodenale*) が原因となる。ヒト回虫は感染後1~2週間で呼吸器症状が出現する。アメリカ鉤虫とズビニ鉤虫は感染後10日程度である⁴⁾。ヒト体内に侵入した幼虫は糞線虫と同じ経路で小腸に達し成虫となる。

e イヌ糸状虫症

イヌ糸状虫 (*Dirofilaria immitis*) が原因である。イヌ糸状虫に感染したイヌを吸血した蚊によって媒介される。急性期に診断されることはほとんどなく、健診で胸部異常陰影を指摘され、肺癌を疑われて摘出された組織から病理学的に診断されることが多い。

f リンパ管フィラリア症

本症の原因はバンクロフト糸状虫 (*Wuchereria bancrofti*) とマレー糸状虫 (*Brugia malayi*) である。本虫による呼吸器症状は熱帯性肺好酸球増多症と呼ばれ、慢性の経過をたどる⁴⁾。熱帯性肺好酸球増多症を起こすのは0.5%未満である。渡航者のリスクは明らかではなく、患者の多くは流行地の外国人である⁶⁾。

検査・診断

a 症候・身体所見

特異的な症状はない (表1)。出身地、国籍、海外渡航歴、食嗜好歴などの患者背景を把握し、寄生虫症の可能性を考える。

b 一般的な検査 (表1)

i) 胸部X線, 胸部CT

イヌ糸状虫症の coin lesion は比較的特徴のある所見だが、その他の肺寄生虫症の胸部画像所見は非特異的であり、他疾患との鑑別が必要である。

ii) 血液検査

末梢血好酸球増多は、特に蠕虫感染でみられ、寄生虫症を疑うきっかけとなる。ただし慢性的に経過する肺寄生虫症では、経過とともに好酸球増多の程度が低くなり、好酸球増多がみられないこともある。

c 診断に必須の検査

患者背景と画像・血液検査から寄生虫症が鑑別に挙げられれば診断に必須の検査はそれほど多くない。寄生虫を検出するか、免疫診断で特異的抗体を検出するかである (表1)。寄生虫の検出は各種検体から虫卵、幼虫、ミクロフィラリアを検出し形態学的・遺伝子学的に同定する。

幼虫移行症では免疫診断が診断に果たす役割は大きい。あくまでも補助診断であり限界を知っておくことが重要である。たとえば、抗体が陰性の場合には検査時期が不適切（感染早期あるいは陳旧性）なのかもしれない。抗体が陽性であっても既感染や非特異的反応を示していることがある。

治療

表2に治療をまとめた。

Advanced

■寄生虫症の診断・治療に困った場合

検査会社が受託している抗寄生虫抗体スクリーニング検査は、一度に12種類の寄生虫（蠕虫）抗体の検査が可能であるが、虫種によって感度・特異度にばらつきがある。免疫診断もひとつの方法だけでなく複数の検査を組み合わせて判断する。12種類以外の寄生虫症の免疫診断や形態学的・遺伝子学的同定は商業ベースでは実施されていない。どの施設でどの寄生虫の検査が可能か、あるいは治療法についての相談は寄生虫学会ホームページの医療関係者向けコンサルテーションフォームより問い合わせが可能である。

文 献

- 1) Yoshida A, et al : Acta Trop 199 ; 105074, 2019
- 2) Nagayasu E, et al : Intern Med 54 : 179, 2015
- 3) Akao N, et al : Parasitol Int 56 : 87, 2007
- 4) Kunst H, et al : Thorax 66 : 528, 2011
- 5) Asato R, et al : Jpn J Trop Med Hyg 20 : 169, 1992
- 6) Boggild AK, et al : Clin Infect Dis 39 : 1123, 2004